·专家共识·

婴幼儿过敏性疾病预防健康教育专家共识

国家卫生健康委妇幼健康中心；中华预防医学会儿童保健分会

摘要：近年来，婴幼儿过敏性疾病（如特应性皮炎、食物过敏、过敏性鼻炎等）在全球范围内发病率上升，成为全球公共卫生的重要挑战。过敏不仅影响婴幼儿生长发育及生活质量，还可能延续至成年期，加重社会和医疗负担。基于“健康中国 2030”战略中儿童健康优先发展的政策导向，加强过敏早期预防是我国妇幼保健体系的重要任务之一。当前过敏预防实践面临诸多挑战：孕期及哺乳期母婴营养干预服务仍需规范、家长对过敏高风险因素认知不足、基层医疗卫生机构健康教育资源不均等。为系统整合国内外研究成果及临床实践经验，国家卫生健康委妇幼健康中心与中华预防医学会儿童保健分会组织国内儿科、儿童保健、医学免疫等领域专家编制本共识，强调“生命早期 1 000 天”的全程防控策略，为我国婴幼儿过敏预防提供了标准化、本土化的实践框架。未来需通过政策支持、医护人员培训及社区宣教等多维度推动专家共识落地，以期降低过敏性疾病负担，助力儿童健康高质量发展。

关键词：过敏预防；孕期；婴儿期；健康教育；过敏风险

DOI: 10.19757/j.cnki.issn1674-7763.2025.05.002

Expert consensus on health education for prevention of allergic diseases in infants and young children

National Center for Women and Children's Health, NHC, PRC; The Child Health Care Branch of Chinese Preventive Medicine Association

Corresponding author: *XU Tao*, *Email*: *xutao6622@ncwchnhc.org.cn*

Abstract: In recent years, the incidence of allergic diseases in infants and young children—including atopic dermatitis, food allergies, and allergic rhinitis—has risen significantly worldwide, posing a major global public health challenge. Allergic diseases not only impair the growth, development, and quality of life of young children in early childhood, but may also persist into adulthood, further exacerbating societal and healthcare burdens. Aligned with the "Healthy China 2030" strategic priority on child health development, strengthening early prevention of allergic diseases has become a critical mission in China's maternal and child health system. However, current practices for allergic disease prevention face multiple challenges: non-standardized maternal nutritional interventions during pregnancy and lactation, insufficient parental awareness of high-risk factors for allergies, and uneven distribution of health education resources in primary healthcare institutions. To systematically integrate global research evidence and clinical expertise, National Center for Women and Children's Health, NICHC, PRC and the Child Health Core Branch of Chinese Preventive Medicine Association organized experts in pediatrics, child health care, and medical immunology to formulate this consensus. It emphasizes a comprehensive prevention strategy targeting "the first 1 000 days of life", establishing a standardized and localized framework for infant allergy prevention in China. The effective implementation of this consensus requires multidimensional efforts—strengthening policy support, training healthcare providers, and promoting community-based health education—to reduce the burden of allergic diseases and promote high-quality development of child health.

Key words: allergy prevention; pregnancy; infancy; health education; allergy risk

1　制定背景

过敏性疾病是婴幼儿期常见的健康问题，对儿童体格生长和心理健康均可产生不良影响，也给家庭和社会带来医疗负担[1-2]。早期过敏预防和干预有助于降低过敏的发生和严重程度，而预防干预具体措施的有效实行与健康教育密不可分。为此，国家卫生健康委妇幼健康中心与中华预防医学会儿童保健分会组织了国内儿科、儿童保健、医学免疫等领域

通信作者：徐韬，Email：xutao6622@ncwchnhc.org.cn

收稿日期：2025-07-07

专家编制本共识，以期为各级医疗卫生机构、托育机构和幼儿园开展科学、规范化的过敏预防健康教育活动实践提供参考，以加强婴幼儿和孕产妇家庭对过敏性疾病的防范意识，同时也避免对婴幼儿过敏性疾病过度关注或过度处理，提高科学养育水平，促进婴幼儿健康成长。本共识中的预防概念涵盖了三级预防，包括采取有效措施消除、减少致敏因素，以降低过敏风险的一级预防；早发现、早诊断、早干预，防止或减缓过敏性疾病发展的二级预防；对症治疗，控制过敏性疾病及其合并症的发生，提高患儿及其家庭日常生活质量的三级预防。

2　流行病学特征

我国儿童过敏性疾病流行广泛。2015 年一项全国性的过敏性疾病流行病学调查结果显示，城市地区 0～24 月龄婴幼儿过敏性疾病现患率为 12.30%[3]，发病高峰在 4～6 月龄。婴幼儿期最常见的过敏性疾病是特应性皮炎和食物过敏。2019 年一项研究显示，我国 1～12 月龄婴儿特应性皮炎患病率为 30.48%，1～<2 岁、2～3 岁幼儿特应性皮炎患病率分别为 19.94% 和 13.79%[4]。2024 年发表的最新研究显示：我国 0～5 岁儿童食物过敏自报患病率为 4.81%，高于 2010 — 2013 年食物过敏自报患病率（3.85%），食物过敏患病率呈上升趋势[5]。此外，过敏相关的呼吸系统疾病也较常见。一项 meta 分析结果显示，2001 — 2021 年我国 0～17 岁儿童青少年过敏性鼻炎总患病率为 18.46%。另有两项关于我国儿童哮喘患病情况的 meta 分析结果显示，我国 0～14 岁儿童哮喘患病率分别为 2.60% 和 4.90%[6]，儿童哮喘患病率总体呈上升趋势[7]。

3　影响因素

3.1　遗传因素

遗传因素是过敏性疾病患病的重要影响因素。一项针对食物过敏家庭聚集性的研究显示[8]，母亲与后代之间的过敏性疾病患病（包括食物过敏、特应性皮炎、哮喘等）均呈显著正相关，父亲与后代哮喘发病显著相关。美国科罗拉多出生队列研究[9] 观察到母亲哮喘和过敏性鼻炎与儿童特应性皮炎/湿疹有显著相关性。澳大利亚基于普通人群的 HealthNuts 队列研究[10] 发现，有父母亲单方过敏史的婴儿中，母亲患有过敏性疾病与婴儿发生食物过敏相关，而父亲患有过敏性疾病与婴儿发生食物过敏未见相关。有研究显示[11] 父母双方均有过敏史的儿童相对于父母单方过敏史患病风险更高。

3.2　环境因素

过敏性疾病是多基因与环境因素共同作用的复杂疾病。环境因素包括母亲孕期及婴幼儿的生活环境、母亲孕期饮食结构、产前或产后用药以及分娩方式、婴儿出生后喂养方式、固体食物引入等。随着过敏病因机制研究的深入，多种与过敏相关的假说逐渐被提出，如卫生假说[12]、微生物假说[13]、环境污染物假说[14] 等。

1989 年卫生假说被首次提出，认为婴幼儿或儿童早期接触相对卫生较差的环境，特别是易于引起感染的环境，有助于减少过敏性哮喘发生。其机制主要是由于婴幼儿或儿童早期受病原体或微生物感染时，免疫系统易于激活 Th1 细胞应答，产生 Th1 型细胞因子，抑制 Th2 细胞分化及其相关细胞因子的释放，从而防止过敏性疾病的发生[15]。

微生物假说则认为，在易感人群中，引起生命早期微生物改变的因素均可能影响过敏性疾病发生，例如剖宫产的婴儿未接触母亲产道中的菌群，则不利于婴儿免疫系统的形成，从而增加过敏性疾病的发生风险[16]。婴儿期使用系统性抗生素会显著增加婴儿特应性皮炎的发生风险，可能是由于肠道微生物群的改变介导了抗生素使用与特应性皮炎之间的关系[17]。

环境污染物假说提出环境污染物不仅直接损伤呼吸道，还与自然过敏原（如花粉）协同作用，加剧过敏性疾病，其中空气污染尤其可以影响哮喘的发病[18]。有研究显示，哮喘的发病与室外空气污染物如二氧化氮（NO_2）、二氧化硫（SO_2）、细颗粒物（$PM_{2.5}$）、可吸入细颗粒物（PM_{10}）等相关，而二手烟暴露则与喘息和哮喘的加重相关[19]。近年来，过敏原经皮肤暴露引发的异常免疫反应亦引起重视，如洗涤剂、清洁剂、表面活性剂等化学物质损害皮肤屏障并引发炎症，在过敏性疾病的发生和发展中起着重要作用。此外，也有多项关于益生元、益生菌、维生素 D 和欧米伽 3 多不饱和脂肪酸与食物过敏相关性的研究，但其因果关联或剂量反应关系的研究证据尚不充分[9]。

4　过敏性疾病早期识别

过敏性疾病的临床症状多样，且缺乏特异性，可同时累及消化道、皮肤、呼吸道，甚至心血管系统。完整详细的病史采集是婴幼儿过敏性疾病诊断的基础，问询病史的重点在于推测可疑过敏原。当婴幼儿出现过敏症状，同时不能用感染或其他器质性疾病原因解释时，应高度怀疑过敏性疾病可能。见表 1。

表 1　婴幼儿过敏性疾病警示征象

疾病	症状
特应性皮炎	确诊特应性皮炎后，若经过规范治疗，皮疹仍无明显好转，且于进食后2　h内出现水肿性红斑、风团或口周、眼周、阴茎等部位肿胀等速发型皮肤表现；或于进食6 ～ 48 h后原好发部位出现红斑、渗出、结痂、苔藓样变等，伴瘙痒等表现时，需警惕食物过敏可能
消化道过敏	反复出现或持续存在：痉挛性腹痛、腹泻、便血、呕吐、反流、肛周发红、便秘、拒食等，可伴或不伴生长发育障碍
过敏性鼻炎、过敏性结膜炎	经常或每年固定时间出现的阵发喷嚏、鼻痒（揉鼻、挖鼻）、鼻塞（张口呼吸、打鼾）、鼻涕；眼痒、流泪、眼红和灼热感等。变应性敬礼（用手指或手掌向上方揉擦鼻子）、变应性皱褶（由于变应性敬礼所致鼻梁处水平皱纹）、变应性暗影（因下眼睑肿胀导致静脉回流障碍而出现的下睑暗影）
过敏性哮喘	反复发作性喘息、咳嗽、胸闷、气促，持续至3岁以后；支气管舒张剂治疗有效或自然缓解；抗哮喘药物治疗有效，停药后复发；非病毒感染导致的间歇性夜间咳嗽

当疑诊过敏性疾病时，应进行必要的体格检查，根据需要加以辅助检查确诊。

5　健康教育核心信息

5.1　*孕产妇和乳母*

核心信息 1：母亲在孕期与哺乳期应均衡膳食，不建议为预防孩子过敏而限制易过敏食物摄入

释义：在母亲孕期，建议饮食均衡、多样化，以满足营养需求[20]。研究显示，孕妇摄入常见过敏性食物（如花生、牛奶、小麦等）可减少其子代的过敏和哮喘相关风险[21]。不推荐限制母亲哺乳期牛奶及其制品饮食以预防牛奶蛋白过敏（cow's milk protein allergic, CMPA）[22-23]。已被确诊食物过敏的孕妇或乳母，在回避致敏食物期间，可用营养价值相似的食物替代。

核心信息 2：没有足够证据推荐母亲孕期与哺乳期为预防孩子过敏，额外补充长链欧米伽 3 脂肪酸（如二十碳五烯酸 (eicosapentaenoic acid, EPA)、二十二碳六烯酸 (docosahexaenoic acid, DHA）、益生元和（或）益生菌

释义：我国居民膳食指南推荐孕期合理补充叶酸，但目的不是为预防过敏。没有充分证据支持孕期与哺乳期母亲额外补充长链欧米伽 3 脂肪酸（EPA、DHA）与降低或增加儿童过敏风险相关。没有充分证据支持孕期与哺乳期母亲服用益生菌/益生元或其他基于特定营养素的膳食补充剂可预防食物过敏。有研究显示，母亲在妊娠后期、哺乳期使用益生菌可预防婴幼儿湿疹发生，但证据有限，仍需高质量临床试验证实[24]。

核心信息 3：母亲孕期避免体重过度增长

释义：孕期体重适宜增长有利于保证母婴营养并获得良好的妊娠结局。母亲孕期体重增长过多可给母婴双方增加许多近期和远期健康风险，其中包括增加子代患哮喘/喘息的风险[25]。建议孕妇应从孕早期开始就遵循《孕前和孕期保健指南（2018）》及《中国居民膳食指南（2022）》中的建议[20,26]，孕期增重需基于孕前身体质量指数（body mass index, BMI）明确孕期适宜增重目标和每个阶段的增重速率，建议孕妇监测和管理体重，使体重增长保持在适宜范围。

核心信息 4：母亲孕期避免滥用抗生素

释义：根据微生物暴露学说（卫生学假说），孕妇滥用抗生素可扰乱母体微生态系统，影响新生儿肠道正常菌群形成，不利于其免疫系统的建立和成熟，从而增加过敏风险。有研究显示，怀孕期间使用抗生素与儿童未来患哮喘风险增加相关[27]。

核心信息 5：母亲孕期避免吸烟或被动吸烟

释义：有研究显示，孕妇吸烟或接触二手烟可增加子代患过敏的风险。烟草的燃烧过程可以产生 60 多种致癌或促癌物质。被动吸烟与主动吸烟摄入烟雾的主要成分基本一致，危害同样巨大，被动吸烟孕妇的胎儿发生出生缺陷和畸形的风险是无烟草暴露者的 2 倍[28]。

核心信息 6：母亲分娩时避免选择无医学指征的剖宫产

释义：有研究显示，经剖宫产出生的儿童患哮喘的风险增加[29]。其原因可能是，剖宫产使新生儿失去接触母亲产道内细菌的机会，并可导致术后母乳喂养延迟，不利于新生儿免疫系统的建立和成熟，从而增加过敏风险。

核心信息 7：母亲孕期应保持积极乐观的心态和愉悦的心情

释义：孕产妇的紧张、焦虑、孤独感、悲伤等不良情绪可导致妊娠剧吐、睡眠障碍、抑郁等，对母亲和胎儿健康均可造成负面影响，其中也包括使子代未来发生哮喘、食物过敏等过敏性疾病的风险升高[30]。鼓励孕妇主动了解妊娠、分娩、育儿等知识，消除对未来、未知的恐惧，增强信心。建议孕妇经常户外活动，保持健康规律生活方式。家人，尤其是丈夫，也要提前做好心理准备，给予孕妇理解与情感支持。必要时应积极寻求专业人士的帮助。

5.2　婴幼儿

核心信息 8：提倡母乳喂养，尽早开奶

释义：婴儿在 6 个月内纯母乳喂养，在引入辅食后也应继续坚持母乳喂养[24]。研究表明，早期暴露于整蛋白配方中的蛋白质可能使婴儿的免疫系统对这些蛋白质产生敏感性，增加以后发生过敏的风险[31]。倡导婴儿出生后吃的“第一口奶”即为母乳。

核心信息 9：无足够证据推荐牛奶蛋白过敏高风险婴儿常规食用部分水解蛋白配方奶粉

释义：任何婴儿配方奶或代乳品都不能与母乳相媲美，但当不能用纯母乳喂养婴儿时，建议首选适合 6 月龄内婴儿的配方奶喂养，普通液态奶、成人奶粉、蛋白粉、豆奶粉等不宜用于喂养婴儿[20]。水解蛋白配方分为部分（适度）水解蛋白、深度水解蛋白和氨基酸配方。有研究显示部分水解蛋白配方对于预防婴幼儿湿疹的发生有保护作用[32,33]，建议无法进行纯母乳喂养的过敏高风险婴儿，可选择通过高质量临床试验证实有效的部分水解蛋白配方奶进行喂养[34]。采用部分水解蛋白配方预防过敏的证据有限，需进行个体化评估，目前指南不支持也不反对[35]。

核心信息 10：不建议使用深度水解、大豆蛋白以及其他动物蛋白来预防婴儿过敏

释义：深度水解蛋白配方奶粉一般用于牛奶蛋白过敏的治疗，不应出于预防目的使用。没有证据表明以大豆蛋白为基础的婴儿配方奶粉能预防过敏，因此不应为此目的而使用。没有证据表明其他动物奶具有预防过敏的作用，例如山羊奶、绵羊奶或马奶，因此也不应出于预防过敏的目的而给予这类奶。没有证据表明谷物饮料具有预防过敏的作用，因此也不应出于预防过敏的目的而给予这类食物[36-37]。

核心信息 11：不建议婴幼儿为了预防过敏额外补充长链欧米伽 3 脂肪酸、益生元和（或）益生菌或其他营养素

释义：由于研究数据的异质性，对于补充欧米伽 3 多不饱和脂肪酸对于婴儿的过敏预防，不能给出最终建议[24]。没有关于婴儿期补充维生素可预防过敏的可靠研究数据。没有充分证据支持婴幼儿服用益生元和（或）益生菌或其他基于特定营养素的膳食补充剂可预防食物过敏。有研究显示，母亲在妊娠后期、哺乳期使用益生菌可预防婴幼儿湿疹发生，但证据有限，仍需高质量临床试验证实[24]。

核心信息 12：婴儿引入辅食的适宜时机是满 6 月龄，无需为预防过敏而回避或延迟易致敏食物的摄入

释义：辅食的引入不应过早或过晚，通常不早于满 4 月龄、不晚于满 6 月龄。建议每次只引入 1 种新的食物，引入后至少适应 2～3 d 再添加其他新食物，密切观察是否出现呕吐、腹泻、皮疹等消化道、皮肤和呼吸道不良反应。有证据表明婴儿在生命第一年膳食的多样性对过敏性疾病的发展具有保护作用，没有证据表明在出生后第一年避免易致敏食物过敏原对食物过敏有预防过敏作用[38]。

核心信息 13：建议在添加辅食后及时引入熟鸡蛋，有利于预防鸡蛋过敏

释义：蛋及蛋类的引入可以从蛋黄开始，将鸡蛋煮熟或蒸透。鸭蛋、鸽蛋、鹌鹑蛋等蛋类的营养价值与鸡蛋类似。如果婴儿引入蛋黄或整鸡蛋后有呕吐、腹泻、严重皮疹等不良反应时应立即停止引入。如果症状严重应及时就医，判断是否为鸡蛋过敏。近年研究显示，推迟鸡蛋及蛋类的引入并不能减少鸡蛋过敏，因此应在婴儿添加辅食时尽早引入鸡蛋[39]。

核心信息 14：建议食物过敏的婴幼儿，应回避明确诊断的过敏食物，并定期进行过敏评估和营养咨询

释义：回避明确诊断的过敏食物是目前临床治疗食物过敏最有效的方法。CMPA 患儿，若为母乳喂养者应继续母乳喂养[22]，母亲的饮食应回避含牛奶的食物，同时应补充钙剂和维生素 D；若为配方奶喂养者，应选用低敏配方（深度水解蛋白或氨基酸配方）替代喂养。除回避过敏食物外，辅食引入原则与健康儿童一致。为避免因食物回避引起营养素获取受限，应在营养师指导下引入适宜的替代食物，必要时进行膳食营养素补充。过敏食物回避过程中，应指导家长学会阅读商品上的食物成分表，避免因意外摄入造成严重后果。食物过敏有随年龄增长而自愈的可能，故应定期监测，建议每 3～6 个月由医生进行重新评估，并及时调整回避性饮食治疗方案。

核心信息 15：婴幼儿期避免发生超重/肥胖，可降低哮喘发生风险

释义：有研究显示超重和肥胖的儿童比正常体重儿童发生哮喘的风险增加[40]。建议婴幼儿均衡健康饮食，限制含糖饮料摄入，定期监测婴儿体格指标，保持健康生长，不盲目追求过快生长。提倡回应式喂养，鼓励进食但不强迫进食。

核心信息 16：已明确过敏症状是由吸入性过敏原引发的，应尽量避免接触过敏原

释义：常见的室内吸入性过敏原有尘螨、霉菌、动物毛皮屑、蟑螂等；常见的室外吸入性过敏原有花粉、霉菌等[41]。针对室内吸入性过敏的预防，建议降低室内湿度、经常开窗通风，定期除尘；衣柜、橱柜可使用干燥剂等除湿防霉；儿童毛绒玩具以及沙发、被褥、床垫等家居用品保持清洁、定时清洗；可选择使用符

合中国 GB/T 24253-2009 标准的防螨面料的床垫；注意蟑螂等害虫的防治，但不过度使用清洁剂和消毒剂等。针对花粉过敏的预防，建议在花粉、树粉浓度较高季节注意关窗，尽量减少户外活动时间，可使用室内空气过滤系统；避免在户外晾晒衣物或床上用品，避免花粉沾染；户外活动时可戴口罩、防花粉眼镜、或鼻腔涂用花粉阻隔剂等切断花粉传播途径。

核心信息 17：对于特应性皮炎的患儿，正确的沐浴方式及使用润肤剂，有助于恢复和保持皮肤屏障功能

释义：在婴幼儿皮肤状态健康时，现有证据尚不推荐经常使用保湿润肤剂以预防湿疹和过敏，即使是有过敏家族史。但对于皮肤明显干燥的婴幼儿，建议在清洁皮肤后使用针对问题性皮肤设计的功效性润肤剂。特应性皮炎患者皮损及非皮损部位均存在不同程度的屏障功能损伤，建议全身使用润肤剂。可在进行基础保湿后进一步用药。沐浴过程中禁止搓澡，以免破坏皮肤屏障。避免使用含有食物蛋白成分的润肤剂或洗发液，如牛奶、花生等，以降低致敏或发生接触性皮炎风险。

6　健康教育方法和评价

健康教育是以传播、教育、干预为手段，以帮助个体和群体改变不健康行为和建立健康行为为目标，以促进健康为目的所进行的系列活动及其过程[42]。在婴幼儿过敏预防工作中，健康教育工作者或妇幼保健人员应向儿童及家长传递有关健康的知识和信息，帮助他们养成良好的行为及生活习惯，同时了解他们是否真正接受了健康信息或采纳了健康行为，或在某一过程中遇到什么问题等，以便及时提供适时必要的帮助。

6.1　常见健康教育形式

6.1.1　人际传播：人际传播包括一对一传播和群体传播。一对一传播是在医院比较常见的健康传播方式，可以通过在门诊、病房等场所，和孕产妇及儿童家长进行沟通，收集孕产妇及儿童家长在婴幼儿过敏预防方面的行为和困惑，同时传播婴幼儿过敏预防的相关知识。群体传播是通过孕妇学校、家长课堂或其他群众交流活动，开展科普讲课、孕产妇及家长座谈、讨论等，系统地传播科普知识[43]。

6.1.2　大众传播：大众传播是指职业性的信息传播机构使用电子和印刷技术，通过广播、电视、网络、报纸、期刊、书籍、新媒体等媒介向范围广泛、为数众多的社会人群进行的信息传播活动。医疗卫生机构可以与大众传播机构联合，积极传播婴幼儿过敏预防知识[44]。

6.2　不同场所的健康教育

6.2.1　院内健康教育：院内健康教育可分为门诊健康教育和住院健康教育。

门诊就医流动性较大，停留时间短，并且就医者的职业、年龄不同，接受教育的能力也不同，教育内容可以以门诊就医者普遍关心的问题为主。通过咨询门诊服务或定期的门诊专题讲座或专题宣传栏完成健康教育计划。具体可通过健康教育处方、候诊教育、门诊教育和随诊教育 4 种方式进行。住院健康教育可分为入院时教育、住院期间教育和出院前教育。入院时教育应以口头教育为主，内容主要应包括医院的规章制度、就医者病情诊断及治疗方案等。住院期间教育采用的方式应多样化，包括讲座、播放电视录像和宣传栏等，主要由护士针对就医者的病情变化进行有效的教育、指导和安慰。出院前教育主要结合就医者的实际情况进行病情及治疗情况的介绍并帮助就医者建立健康的生活习惯。

6.2.2　院外健康教育：院外健康教育可分为社区健康教育和社会宣传教育。

社区健康教育需要结合基本公共卫生服务中孕产妇和 0～6 岁儿童健康管理工作[45]，开展婴幼儿过敏预防的内容。医务人员可利用孕妇到社区建立母子健康档案、医生进行新生儿随访、儿童定期体检以及儿童预防接种等医护见面的时机，对孕早期孕妇尽早传播过敏预防知识，尤其是孕期注意事项；对儿童家长开展过敏预防知识的一对一传播，并在体检中及时发现过敏问题，及时给予治疗。社会宣传教育可通过当地卫生主管部门的部署及医院本身的工作需要，向社会人群进行健康宣传倡导，如开展义诊、举办卫生科普展览；通过社区电视、广播等传统传播方式，或通过官方公众号和视频号等新媒体，或通过农村大喇叭等方式，广泛宣传婴幼儿过敏预防知识。

6.3　健康教育处方

近年来，健康教育处方的应用逐渐得到重视和普及。它是发放给健康教育目标群体有针对性的医嘱和宣传材料，院内和院外健康教育均适用，可作为口头教育的补充完善，便于保存阅读，是一类很受欢迎的文字传播形式，能有效指导目标人群进行自我保健和家庭保健[46]。

6.3.1　拟定健康教育处方原则

① 科学性：这是任何健康教育传播材料设计中最重要的原则之一。健康教育处方传播的卫生知识必须要有科学依据，不能将道听途说、一己之见、无

科学论证的信息要点写在健康教育处方中。

② 实用性：如果健康教育处方中传播的保健知识是目标人群难以做到或难以实现的，健康教育处方就失去了实用的意义。因此健康教育处方应具有可操作性，使目标人群一看就懂，一做就会。其内容应以基本、简单、重要、有用为原则。语言要通俗易懂、精练、方便阅读。

③ 针对性：健康教育处方要“一病一议”，不宜在一个处方上同时论及数种疾病。当然，健康教育处方也不能完全“公式化”，要针对不同的疾病特点、不同层次的患者突出健康教育处方的“个性化”，提出具有针对性的健康教育具体指导方案。

6.3.2　健康教育处方内容：健康教育处方内容可包含合理营养、加强体育锻炼、科学控制体重等针对普遍目标群体的健康生活方式倡议，也可专门针对患有某种疾病的人群，内容包括病因、症状、治疗原则和自我保健、康复方法等。婴幼儿过敏预防健康教育处方示例见附表 1 和附表 2。

6.4　健康教育实施步骤

预防过敏的健康教育的实施可以采取以下步骤：

① 需求评估：进行针对目标人群（如父母、儿童、教育工作者等）的需求评估，了解他们对过敏预防的知识水平、意愿和需求。

② 制定计划：根据需求评估结果，制定具体的过敏预防健康教育计划。计划可能包括健康教育内容、教学方法、教材和资源等。

③ 教育实施：根据健康教育计划，进行过敏预防的健康教育实施。可通过人际传播、大众传播等方式，确保内容易于理解、针对性强，并提供互动和参与的机会。

④ 评价效果：在教育实施后，进行评价以了解健康教育效果。

⑤ 修订改进：根据评价结果，对健康教育计划进行修订和改进。根据参与者的反馈和需求，调整健康教育内容、教学方法和资源，以提高健康教育效果。

⑥ 持续跟进：过敏预防的健康教育是一个持续的过程。定期进行回顾和更新，确保健康教育内容与最新的科学知识和实践相符。定期评估健康教育效果，并根据需要进行进一步的改进和提升。

6.5　健康教育评价方法

① 设计评价方案。包括目的、现有资源、评价方法、评价指标、评价内容、资料收集方法、资料收集方案等。过敏预防评价指标可以包括知识水平的提升、行为改变的程度、参与者满意度等指标。

② 收集资料。通过查阅资料、观察、个别访谈、专题小组讨论、问卷调查等方式进行收集。

③ 分析资料。根据资料收集情况确定分析方法。

④ 完成评价报告。包括评价目的、人员组成，评价内容与方法，评价对象过敏预防的知识水平、信念改变、行为改变，评价参与者的满意度、效果持久性、社会影响等，经验与不足之处、改进意见等。

附表 1　婴幼儿过敏预防健康教育处方（孕产妇与乳母版）

姓名：	性别：	年龄：	
健康指导建议			
□ 母亲孕期与哺乳期应均衡膳食，不建议为预防孩子过敏而限制易过敏食物摄入			
□ 不建议母亲孕期与哺乳期为了预防孩子过敏而额外补充长链欧米伽3脂肪酸、益生元和（或）益生菌			
□ 母亲孕期合理增重			
□ 母亲孕期在医生指导下合理使用抗生素			
□ 母亲孕期避免吸烟或被动吸烟（吸二手烟）			
□ 母亲分娩听从医嘱合理选择分娩方式			
□ 母亲孕期保持积极乐观的心态和愉悦的心情			
其他健康指导建议			
医生/指导人员签名：	咨询电话：		日期：　　年　　月　　日
使用说明			
* 面向对象：孕产妇与乳母			
* 使用方法： 1. 医务人员使用该处方，结合孕产妇与乳母的基本情况、健康危险因素等，提供有针对性的健康指导； 2.如果医务人员在某些健康指导建议的“□”中打“√”，则提示此建议为需要重点关注的内容； 3.本处方不能替代医务人员开具的医疗处方，主要用于健康生活方式指导。			

附表 2　婴幼儿过敏预防健康教育处方(婴幼儿家长版)

姓名:	性别:	年龄:	
健康指导建议			
□ 提倡母乳喂养, 尽早开奶			
□ 母乳喂养新生儿发生牛奶蛋白过敏时, 建议继续母乳喂养			
□ 如果母乳喂养不充分或无法进行母乳喂养, 则应给予婴儿配方奶粉			
□ 6月龄内无法进行纯母乳喂养的过敏高风险婴儿, 可选择部分水解蛋白配方奶粉进行喂养			
□ 不建议使用深度水解蛋白、大豆蛋白以及其他动物蛋白来预防婴儿过敏			
□ 不建议婴幼儿为了预防过敏额外补充长链欧米伽3脂肪酸或其他营养素			
□ 婴儿引入辅食的适宜时机是满6月龄, 无需为预防过敏而回避或延迟易致敏食物的摄入			
□ 建议在添加辅食后及时引入熟鸡蛋, 有利于预防鸡蛋过敏			
□ 建议食物过敏的婴幼儿回避进食明确引发过敏症状的食物, 并定期进行过敏评估和营养咨询			
□ 已明确过敏症状是由吸入性过敏原引发的, 应尽量避免接触过敏原			
□ 使用润肤保湿产品预防过敏的证据不充分, 但对于皮肤明显干燥的婴幼儿, 建议可在清洁皮肤后使用保湿霜			
□ 对于特应性皮炎的患儿, 正确的沐浴方式及使用功效性润肤剂为基础治疗, 有助于恢复和保持皮肤屏障功能			
□ 婴幼儿期避免发生超重/肥胖, 可降低过敏发生风险			
其他健康指导建议			
医生/指导人员签名:	咨询电话:		日期:　　年　　月　　日
使用说明			
* 面向对象: 婴幼儿家长			
* 使用方法: 1. 医务人员使用该处方, 结合婴幼儿基本情况、健康危险因素等, 提供有针对性的健康指导; 2.如果医务人员在某些健康指导建议的“□”中打“√”, 则提示此建议为需要重点关注的内容; 3. 本处方不能替代医务人员开具的医疗处方, 主要用于健康生活方式指导。			

执笔专家名单(按执笔章节排序)　徐韬(国家卫生健康委妇幼健康中心)、陈晶(厦门市妇幼保健院)、王硕(国家卫生健康委妇幼健康中心)、王念蓉(重庆市妇幼保健院)、李光辉(北京妇产医院)、胡燕(首都医科大学附属北京儿童医院)、余晓丹(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心)、游川(北京妇产医院)

制订专家名单(按单位和姓名首字汉语拼音顺序排序)　北京妇产医院(李光辉, 游川); 北京市朝阳区妇幼保健院(尚煜); 重庆市妇幼保健院(王念蓉); 广东省妇幼保健院(吴婕翎); 国家卫生健康委妇幼健康中心(王硕, 徐韬); 贵阳市妇幼保健院(骆艳); 湖南省儿童医院(钟燕); 四川省妇幼保健院(王红); 首都儿科研究所(李涛, 张彤); 山东省妇幼保健院(李燕); 首都医科大学附属北京儿童医院(胡燕); 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心(陈同辛, 余晓丹); 上海交通大学医学院附属新华医院(盛晓阳); 厦门市妇幼保健院(陈晶); 原中国疾病预防控制中心妇幼保健中心(王惠珊)

利益冲突声明　所有作者声明无利益冲突。

参考文献

[1] 中华儿科杂志编辑委员会, 中华医学会儿科学分会. 儿童过敏性疾病诊断及治疗专家共识[J]. 中华儿科杂志, 2019(3): 164-171.

[2] 张亚钦, 武华红, 宗心南, 等. 中国九城市七岁以下儿童生长迟缓影响因素的调查[J]. 中华儿科杂志, 2021(9): 743-751.

[3] 王硕, 蒋竞雄, 王燕, 等. 城市 0～24 月龄婴幼儿过敏性疾病症状流行病学调查[J]. 中国儿童保健杂志, 2016, 24(2): 119-122.

[4] Guo Y, Zhang H, Liu Q, et al. Phenotypic analysis of atopic dermatitis in children aged 1-12 months: elaboration of novel diagnostic criteria for infants in China and estimation of prevalence[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2019, 33(8): 1569-1576.

[5] 琚腊红, 赵丽云, 魏潇琪, 等. 中国 0～5 岁儿童食物过敏流行现况及影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2024, 45(6): 817-823.

[6] 全国儿科哮喘协作组, 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所. 第三次中国城市儿童哮喘流行病学调查[J]. 中华儿科杂志, 2013(10): 729-735.

[7] 周舒, 黄嘉, 梁雅丽, 等. 中国儿童哮喘患病率及其危险因素的 meta 分析[J]. 国际流行病学传染病学杂志, 2020, 47(3): 253-259.

[8] Tsai HJ, Kumar R, Pongracic J, et al. Familial aggregation of food allergy and sensitization to food allergens: a family-based study[J]. Clin Exp Allergy, 2009, 39(1): 101-109.

[9] Venter C, Palumbo MP, Sauder KA, et al. Incidence and timing of offspring asthma, wheeze, allergic rhinitis, atopic dermatitis, and food allergy and association with maternal history of asthma and allergic rhinitis[J]. World Allergy Organ J, 2021, 14(3): 100526.

[10] Koplin JJ, Allen KJ, Gurrin LC, et al. The impact of family history of allergy on risk of food allergy: a population-based study of infants[J]. Int J Environ Res Public Health, 2013, 10(11): 5364-5377.

[11] Ravn NH, Halling AS, Berkowitz AG, et al. How does parental history of atopic disease predict the risk of atopic dermatitis in a child? A systematic review and meta-analysis[J]. J Allergy Clin Immunol, 2020, 145(4): 1182-1193.

[12] Rook GA. Regulation of the immune system by biodiversity from the natural environment: an ecosystem service essential to health[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2013, 110(46): 18360-18367.

[13] Huang YJ, Marsland BJ, Bunyavanich S, et al. The microbiome in allergic disease: current understanding and future opportunities-2017 PRACTALL document of the American academy of allergy, asthma & immunology and the European academy of allergy and clinical immunology[J]. J Allergy Clin Immunol, 2017, 139(4): 1099-1110.

[14] Guarnieri M, Balmes JR. Outdoor air pollution and asthma[J]. Lancet, 2014, 383(9928): 1581-1592.

[15] Venter C, Pereira B, Grundy J, et al. Prevalence of sensitization reported and objectively assessed food hypersensitivity amongst six-year-old children: a population-based study[J]. Pediatr Allergy Immunol, 2006, 17(5): 356-363.

[16] 罗宇阳, 吴薇岚, 吴葆宁, 等. 南宁市 0～24 个月婴幼儿过敏性疾病的临床特征及相关影响因素分析[J]. 中国妇幼保健, 2018, 33(1): 132-135.

[17] Hoskinson C, Medeleanu MV, Reyna ME, et al. Antibiotics taken within the first year of life are linked to infant gut microbiome disruption and elevated atopic dermatitis risk[J]. J Allergy Clin Immunol, 2024, 154(1): 131-142.

[18] Boldogh I, Bacsi A, Choudhury BK, et al. ROS generated by pollen NADPH oxidase provide a signal that augments antigen-induced allergic airway inflammation[J]. J Clin Invest, 2005, 115(8): 2169-2179.

[19] 岳春兰, 田执梁. 空气污染与儿童哮喘发病机制的研究进展[J]. 中国儿童保健杂志, 2018, 26(5): 510-512, 517.

[20] 中国营养学会. 中国居民膳食指南(2022)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2022.

[21] Halken S, Muraro A, de Silva D, et al. EAACI guideline: preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update)[J]. Pediatr Allergy Immunol, 2021, 32(5): 843-858.

[22] 中华医学会儿科学分会新生儿学组, 中华儿科杂志编辑委员会. 新生儿牛奶蛋白过敏诊断与管理专家共识(2023)[J]. 中华儿科杂志, 2024, 62(1): 12-21.

[23] 周薇, 赵京, 车会莲, 等. 中国儿童食物过敏循证指南[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(8): 572-583.

[24] Kopp MV, Muche-Borowski C, Abou-Dakn M, et al. S3 guideline allergy prevention[J]. Allergol Select, 2022, 6: 61-97.

[25] Liu S, Zhou B, Wang Y, et al. Pre-pregnancy maternal weight and gestational weight gain increase the risk for childhood asthma and wheeze: an updated meta-analysis[J]. Front Pediatr, 2020, 8: 134.

[26] 中华医学会妇产科学分会产科学组. 孕前和孕期保健指南(2018)[J]. 中华妇产科杂志, 2018, 53(1): 7-13.

[27] Ahmadizar F, Vijverberg SJH, Arets HGM, et al. Early-life antibiotic exposure increases the risk of developing allergic symptoms later in life: a meta-analysis[J]. Allergy, 2018, 73(5): 971-986.

[28] 李照青, 戴亚欣, 赵亚玲, 等. 中国妇女孕期被动吸烟与不良妊娠结局关系的 meta 分析[J]. 中国循证医学杂志, 2015, 15(7): 816-823.

[29] Chu S, Zhang Y, Jiang Y, et al. Cesarean section without medical indication and risks of childhood allergic disorder, attenuated by breastfeeding[J]. Scientific reports, 2017, 7(1): 9762.

[30] Flanigan C, Sheikh A, DunnGalvin A, et al. Prenatal maternal psychosocial stress and offspring's asthma and allergic disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Clin Exp Allergy, 2018, 48(4): 403-414.

[31] 张玉梅, 毛帅, 谭圣杰, 等. 水解乳蛋白与婴幼儿健康的研究进展[J]. 中国食品卫生杂志, 2022, 34(2): 189-195.

[32] 国家卫生健康委. 食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则: GB 25596-2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

[33] Sicherer SH, Burks AW. Maternal and infant diets for prevention of allergic diseases: understanding menu changes in 2008[J]. J Allergy Clin Immunol, 2008, 122(1): 29-33.

[34] Inuo C, Tanaka K, Suzuki S, et al. Oral immunotherapy using partially hydrolyzed formula for cow's milk protein allergy: a randomized, controlled trial[J]. Int Arch Allergy Immunol, 2018, 177(3): 259-268.

[35] Vandenplas Y, Broekaert I, Domellöf M, et al. An ESPGHAN position paper on the diagnosis, manage-

ment, and prevention of cow's milk allergy[J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2024, 78(2): 386-413.

[36] Castenmiller J, Hirsch-Ernst KI, Kearney J, et al. Efficacy of an infant formula manufactured from a specific protein hydrolysate derived from whey protein isolate and concentrate produced by Société des Produits Nestlé S. A. in reducing the risk of developing atopic dermatitis[J]. EFSA J, 2021, 19(6): e06603.

[37] Morency ME, Birken CS, Lebovic G, et al. Association between noncow milk beverage consumption and childhood height[J]. The American journal of clinical nutrition, 2017, 106(2): 597-602.

[38] 陈同辛, 洪莉, 王华, 等. 中国婴儿轻中度非 IgE 介导的牛奶蛋白过敏诊断和营养干预指南[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2022, 37(4): 241-250.

[39] Togias A, Cooper SF, Acebal ML, et al. Addendum guidelines for the prevention of peanut allergy in the United States: report of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases-sponsored expert panel[J]. J Allergy Clin Immunol, 2017, 139(1): 29-44.

[40] Gilliland FD, Berhane K, Islam T, et al. Obesity and the risk of newly diagnosed asthma in school-age children[J]. Am J Epidemiol, 2003, 158(5): 406-415.

[41] 北京医学会过敏变态反应学分会. 过敏性疾病诊治和预防专家共识(Ⅱ)[J]. 中华预防医学杂志, 2022, 56(11): 1527-1539.

[42] 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心, 中华预防医学会儿童保健分会. 婴幼儿重点呼吸道病毒感染性疾病预防健康教育专家共识[J]. 中国妇幼卫生杂志, 2024, 15(1): 1-6.

[43] 何丽, 方俊群, 熊书晗, 等. 湖南省辖区妇幼健康教育模式的探讨与实践[J]. 中国妇幼卫生杂志, 2022, 13(2): 77-80.

[44] 于佳, 吴燕燕, 肖辉云, 等. 微信公众平台在妇幼健康教育中的应用分析[J]. 中国妇幼保健, 2019, 34(14): 3160-3163.

[45] 杨焕义. 健康教育在儿童保健护理中的应用价值研究[J]. 中国农村卫生, 2020, 12(24): 9, 6.

[46] 中国健康教育中心. 健康教育处方[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2020.

《中国妇幼卫生杂志》投稿要求

尊敬的各位专家、读者和作者：

为保证《中国妇幼卫生杂志》稿件质量, 避免学术不端行为的发生, 请在使用网上投稿采编系统提交稿件的同时, 提供相关证明材料。特此通知。

1. 介绍信及授权书：需由所有作者亲笔签署, 单位加盖公章, 模板可在网站上下载, 网址为：https://yzws.cbpt.cnki.net/。

2. 基金项目证明：如为基金项目稿件, 需在文章首页底部标注基金项目名称和编号, 另需提供基金项目证明复印件, 文件中应涵盖项目名称和项目编号, 并加盖公章。

3. 伦理委员会批件：如论文的主体是以人为研究对象的试验时, 作者应该说明其遵循的程度是否符合负责人体试验的委员会(单位性的、地区性的或国家性的)所制定的伦理学标准, 请提供该委员会的批准文件复印件(含批准文号), 并在正文中说明伦理委员会获批情况(注明批准文号)及受试对象(或其监护人)是否知情同意。

注：介绍信及授权书、基金项目证明、伦理委员会批件扫描版需在投稿采编系统打包上传。

《中国妇幼卫生杂志》编辑部